جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : شيماء عبدالله عبدالمؤمن عبدالله
المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** الهرم **العنوان :** احمد مسلم
رقم البطاقة : 28112070101406 **رقم التليفون :** 01101102871 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 11-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 07-12-1981 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي تراستوزوماب تحت الجلد و بيرتوزوماب(فيسجو) [14117] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: شيماء عبدالله عبدالمؤمن عبدالله
National ID: 28112070101406

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPT

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

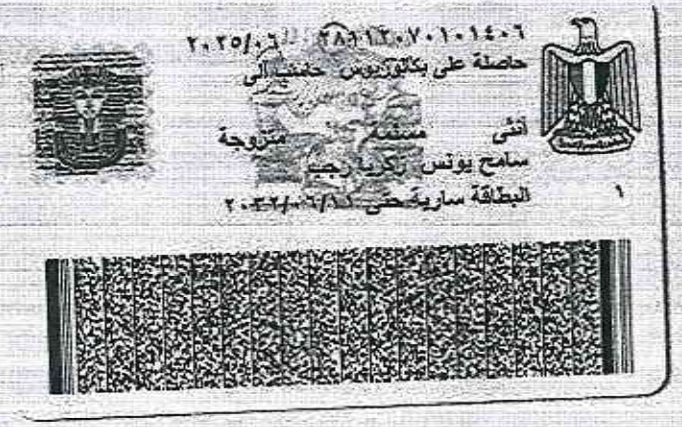
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Phesgo) Subcutaneous trastuzumab and pertuzumab)

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين


جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية
شيماء
عبدالله عبدالمؤمن عبدالله
٩ ش احمد مسلم
الهرم - الجيزه
٢٨١١٢٠٧٠١٠١٤٠٦
LF1543935

A7


٢٨٥١٢٠٧٠١٠١٤٠٦
٢٠٢٥/٠٦/
حاصلة على بكالوريوس حاسبات الى
انثى مسلمة
متزوجة
سامح يونس زكريا رجب
١
البطاقة سارية حتى ٢٠٣٢/٠٦/

Name: شيماء عبدالله عبدالمؤمن عبدالله	
MR. : 4771	

Detailed Medical Report

السيد	

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالتها

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انها

The patient is a 71.2-kg woman with triple-positive right breast cancer who has been treated with a TCHP regimen through week 16 of therapy and is scheduled to receive phesgo cycle 8 on February 12. The most recent echocardiogram performed on November 12 demonstrated a left ventricular ejection fraction of 63%, and the taxol dose was adjusted to 80 mg/m².

The patient received neoadjuvant chemotherapy consisting of 7 cycles of phasgo, 6 cycles of taxol, and carboplatin (CT2 N1) followed by breast conserving surgery, achieving a complete response for the surgical port. Post-operatively, she was placed on an aromatase inhibitor and Zoladex.

On May 16, the patient was noted to have a pre-radiation breast cancer status of CT2 N1, moderately differentiated invasive ductal carcinoma (IDC) with ER 6/8, PR 3/8, HER2 3+, and REC 6. She was treated with TCHP starting March 11, 2026, and underwent radiation therapy with breast conserving surgery, achieving a complete response with N0/17 nodes. She was then started on Zoladex, Femara, and phesgo (C8) with an ejection fraction of 645 on March 9, 2026.

On July 26, the patient's ejection fraction was 64% and she was scheduled for phesgo cycle 10 and Femara/Zoladex with a due date of August 8.

On August 16, the patient completed the port for phesgo cycle 11, Zoladex, and Femara, and was scheduled for phesgo cycle 12.

The patient has completed 12 cycles of phesgo to date.

تحريرا في ,

التاريخ :	20-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : dina makram

يعتمد ,

جوستاف روسي

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

السبع المصرية صحة مصر

04/06/2026

MDT FORM

Name:	Shimaa Adallah Abd Elmoamen Adallah	**MRN:**	4771
Age:	44 Y	**ID:**	28112070101406
Menopausal Sta	PRE	**Phone:**	01128230413
NRS SCORE:	PS 1	**Marital Status:**	MARRIED (oldest 8 years youngest 3)
BMI:	25	**Family History:**	-VE
CO Morbidity:	NAD	**Reason Of MDT:**	POST OP FOR ADJ TTT

Clinical Data:

BX: IDC G2

ER: 6/8 **PR:** 3/8 **HER2:** +3 **KI67:**

Sonomammography:
PRE T2 N1 M0

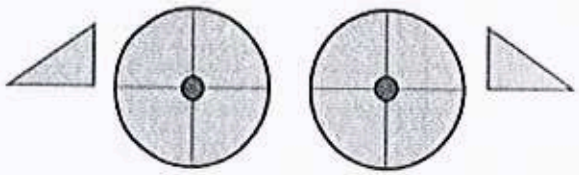
Mets Workup:
POST NACT

History:
RT BCS + ALND (0/17) ,,,,,, FREE MARGINS,,,,,,,,, PT0 PN0 ....PCR
HEALED WOUND AND DRAIN REMOVED

Recommendations:

MDT Outcome & Plan
continue adjuvant Phesgo and PORT
ADJUVANT HORMONAL TTT TAM

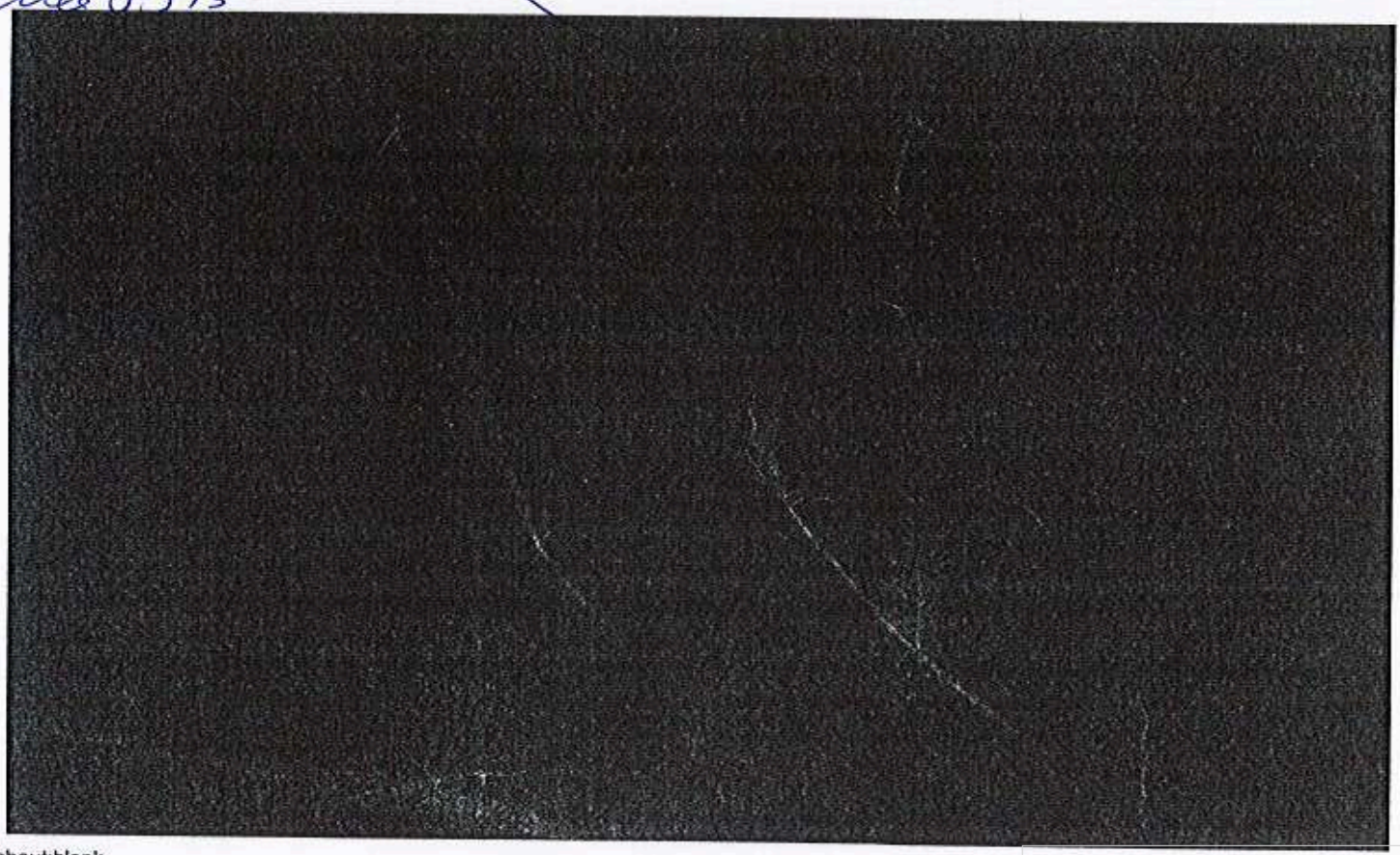
R L



TNM

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
د/ نرمين مصطفي					



مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

السيدات المصريات أولاً صحة مصر

MDT FORM 2 / 9 / 2025 G

Name	[illegible]	MRN	
Age	43yrs	ID	[illegible]
Menopausal status	premenopausal	Phone	[illegible]
NRS SCORE		Marital status	[illegible]
BMI		Family history	
CO morbidity	not sp or HTN	REASON OF MDT	New

Clinical Data

BX:

ER:	PR:	HER 2:	KI67:
6/8	3/8	1+3	

Sonomammography: Rt LOQ mass 2.X1.8cm c Rt axillary L.N 1.8X1.8cm

Mets Workup: PET/CT 11/8/2025 - Rt breast LOQ 1.7cm SUV 8.4 - Rt axillary L.N 1.9cm SUV 11.5

R L

CT2 N1

TNM

EF 60%

Recommendations: Suggested mesentery peritoneal & metastatic active nodules largest 1cm SUV 1.2 for

Case of Rt LABC CT2 N1 for MRI Abd Pelvis + T.M CXR

MDT OUTCOME & PLAN

If Not mets for (R) CA 15-3 CA 125

-Rt. Abd Pelvis & Ups + NACT TTCP

Tumor markers then Remark

Then ... Clinical ... Steroid ... HP x 6 cycles

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
[illegible]	Dr Hisham 21/9/2025	[illegible]			

Patient Name	:	Request No.	: 13003037
Patient No.	: 28112070101406	Request Date	: 18/08/2025
Path No.	: SR-1137/25	Verification Date	: 21/08/2025
Sex	: Female	Financial Category	:
Age	: 43 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc	:	Registered by	: Mrs.Mayada Hega

Pathology Report

CLINICAL DATA
Right breast mass.

NATURE OF SPECIMEN
Block &slide revision.

GROSS EXAMINATION
One block labelled by (1337-25 &23 slides were received.

MICROSCOPIC EXAMINATION
- Histological type: Invasive duct carcinoma.
- Grade (differentiation +nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+3+2) Grade 3
- DCIS: Absent
- Angioinvasion: Absent.
- Perineural invasion: Absent.
- IPT (Positive control showed appropriate reactivity) :
- ER:Moderate nuclear reaction in 60 % tumor cells (Allred score 6/8)
- PR: Weak nuclear reaction in 5 %tumor cells (Allred score 3/8)
- HER2: Strong complete membrane reaction in >10 % of tumor cells (score 3+)

Diagnosis
Right breast mass, block &slide revision :
Invasive duct carcinoma, Grade 3
IPT:
- ER: Positive(score 6/8).
- PR: Positive (score 3/8).
- HER2: Positive (score 3+).

Verified by :
Dr.Heba Hasan

Room No.(4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche- Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Name: Mrs. Shaimaa Abdallah Abdel-Mo'men

Date: 10/7/2025 ID:1123020740 Acc.:291259173

Referring Prof. Dr.: Ali Hasoob.

Computed mammography & ultrasonography examination of both breasts, revealed:

Indication: right breast lump

- (ACR c).
- Right LOQ circumscribed slightly irregular dense mass lesion.
- Left retro-areolar tubular dense lesion.
- No architectural distortion.
- No left spiculated dense mass lesions.
- No suspicious micro-calcific clusters.
- Normal skin thickness and contour.

Ultrasonographic examination showed:

- Increased glandular elements with mottled appearance.
- Right LOQ well-defined lobulated heterogenous hypoechoic solid mass lesion, measures 20 x 18 mm, located at 7 o'clock away from nipple by 4.9 cm (corresponding to palpable lump).
- No right cystic lesions.
- No left cystic of solid mass lesions.
- No dilated retro-areolar ducts.
- Normal skin thickness.
- Multiple right axillary lymph nodes enlargement with muffled hilum and rounded shape, the largest one measures 18 x 18 mm.

Opinion:

- Right LOQ malignant mass lesion with ipsilateral metastatic axillary lymph nodes (BIRADS 5).
- Normal left breast (BIRADS 2).

Recommendation:

- Ultrasound guided Tru-cut biopsy of right LOQ mass lesion.
- Dynamic MRI breast is recommended.

Truly yours;
Dr. Asma' Ahmed, MSc

Name: Mrs. Shaimaa Abdallah Abdel-Mo'men

BIRADS scoring is the breast imaging and reporting data system for classifying the radiological diagnosis of breast lesions:

- BIRADS 0: Incomplete - need additional imaging evaluation or comparison with previous films.
- BIRADS 1: Normal examination - nothing to comment on - Routine mammography screening is recommended.
- BIRADS 2: Benign findings - routine mammography screening is recommended.
- BIRADS 3: Probably benign <2% malignancy - short interval follow-up is suggested.
- BIRADS 4: Suspicious >2 but <95% - Biopsy should be considered.
  - 4A: low suspicion of malignancy: 2-20%.
  - 4B: Mod suspicion of malignancy: 20-50%.
  - 4C: High suspicion of malignancy: 50-90%.
- BIRADS 5: Highly suspicious of malignancy >95% - appropriate action should be taken.
- BIRADS 6: Known - biopsy proven malignancy. Surgical excision when clinically appropriate.

American college of radiology (ACR) scoring of breast density:

- ACR, a: almost entirely fatty.
- ACR, b: scattered areas of fibro-glandular density.
- ACR, c: heterogenously dense.
- ACR, d: extremely dense.

Name: Mrs. Shaimaa Abdalla Abdel-Moamen Abdalla

Date: 26/8/2025 ID:2125003732 Acc.:5162944

MRI of the abdomen and pelvis with IV contrast using different pulse sequences in different planes, revealed:

- Average sized liver with no focal lesions, pathological enhancement or biliary tree dilatation.
- Normal MR appearance of the spleen, pancreas and both kidneys.
- No para-aortic or pelvic lymph nodes enlargement.
- Normal urinary bladder and uterus.
- No adnexal lesion apart from right ovarian simple cyst.
- Congested pelvic veins
- Evidence of small umbilical hernia.
- No ascites.
- Clear lung bases.

Conclusion:

- Small umbilical hernia.
- Congested pelvic veins.
- No evidence of metastatic deposits.

Truly yours;
Dr. Ahmad Rashad, MD

HOTLINE 19173 G-CERT